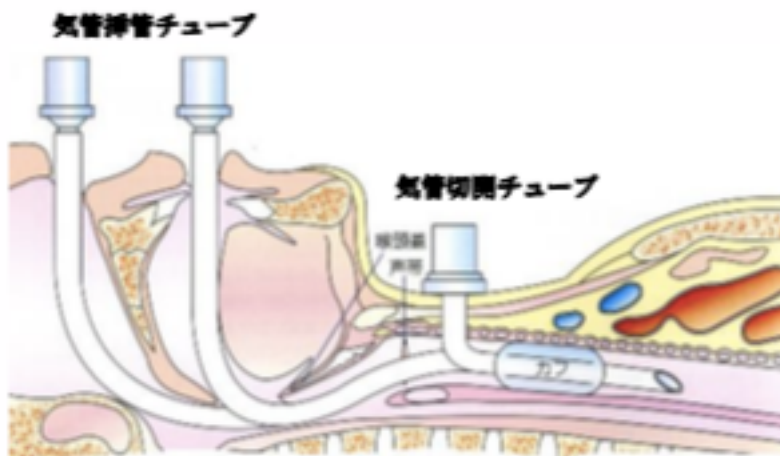


どうして気管切開？

気管切開の利点と欠点



カフなし

カフあり

- * 人工呼吸装着していない場合向き
- * 誤嚥のリスクが低い場合
- * 小児に使用される事が多い

- * 気管切開直後はこのタイプ
- * 人工呼吸器装着している場合向き
- * カフ圧の調整必要
- * サイドチューブ付きもあり



気管切開チューブ

側孔なし



G型標準型気管切開チューブ

側孔あり

- * チューブに孔がないタイプ

- * チューブの湾曲部に孔あり
- * 発声訓練向き
- * 単管と複管両方あり



コーケンIPカニューレ単管タイプ



スピーチカニューレ

発声用バルブを付けているとき

呼気の流れ

発声用バルブが閉じて空気が声門を通過し、口に抜けるため発声ができます。

吸気の流れ

発声用バルブが開いて、気管切開孔から空気が入ります。



レティナ

アジャスタブルフランジ気管切開チューブ
GBアジャストフィット

- * 単回使用気管切開チューブ
- * シリコン製で柔らかい
- * 病状が安定している
- * 長期気管切開孔の維持に使用

- * 長さを調整することが可能
- * 肥満体型でも挿入可能



吸引時間は痰が引ける限りやめないの？

気道分泌物が引けるからと言って、ずっと吸引し続けていませんか？吸引をしている間の患者は、息ができないのです。さらに吸引で気道内の air も気道分泌物と一緒に吸引され、肺泡虚脱や低酸素血症を招く可能性があります。

1 回の吸引時間は最大でも10～15秒以内とし、できるだけ短時間でいきましょう。吸引している間は患者と一緒に息を止めて行ってみましょう。

